EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 81171
SERVICIO : UTI HSC
FECHA : 2024-03-22 10:02:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: BERNARDINA ALBORNOZ BUSTOS			RUN	: 7.668.957-1
F.Nac	: 01-01-1950	Edad	: 74 AÑOS, 2 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: MOISES 1660			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 946171095		
Fecha Ingreso	: 2024-03-11	Fecha Egreso	: 2024-03-22 10:02:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. R10.1-DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE SUPERIOR

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Pancreatitis aguda necro hemorrágica
- Colecciones peripancreáticas y perirrenales
- Pancreatitis crónica de etiología en estudio
2. HUN leve derecha, 2° compresión extrínseca (colección)
3. Anemia ferropénica leve
4. Cáncer de cuerdas vocales en seguimiento (2021: cx+ Rö)
5. HTA de reciente diagnóstico

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. K85-PANCREATITIS AGUDA. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. N13.4-HIDROURETER. (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. D50-ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes descritos, consulta por cuadro de dolor abdominal de dos días de evolución asociado a episodios febriles, que no cede a tratamiento analgésico en domicilio. Se solicitaron exámenes con perfil hepático y enzimas pancreáticas en rango normal, PCR 170. GB 11600. TC AP c/c muestra pancretaitis necrohemorrágica, colecciónes intrabdominal, una de ellas comprime extrínsecamente ureter derecho, con HUN moderada. Se ingresa a UTI para manejo.
Evolución en UTI:
- Hemodinamico: HTA bajo tratamiento con amlodipino, mantiene PA estable durante su hospitalización.
- Hematología: Con anemia ferropénica leve. Se indica tto. al alta.
- Respiratorio: Ventilando espontáneo, sin requerimiento de FiO2 suplementario durante toda su hospitalización. UMA (-)
- Infeccioso: Por colecciones IA, completó tratamiento por 7 días con meropenem (suspendido 18/03/24), parámetros inflamatorios bajos. Manejo conservador de colecciones.
- Renal/Urología: Función renal conservada, orina sin sangre, se mantiene bajo vigilancia de fx renal. Por HUN moderada se realizó UroTC, evaluación urología, desestima manejo especialidad por ahora. Solicito UroTC de control el cual muestra HUN leve (en regresión), por lo que se mantiene manejo conservador. Control uroTc en 15 días más
- Metabólico: Sin conflictos glicémicos, vigilar. Presentó hipocalcemia leve ya corregida, con Mg normal, PTH baja (4.6), lo cual pudiera ser 2° a antecedente de radioterapia. Por el momento vigilar, una vez estabilizada se puede realizar estudio imagen paratiroides (ambulatorio). Sin hipocalcemia durante hospitalización
- Gastro: Dentro avance estudio etiológico de pancreatitis crónica, destaca: sin hipertrigliceridemia severa, complemento normal, Inmunoglobulina normal, cinética fierro ok (leve déficit), CA 19-9, AFP y CEA negativos.

Eco abdominal sin alteraciones morfológicas hepáticas y de la vía biliar. EDA pangastropatía congestiva; metaplasia intestinal gástrica del predomio antral sospechada endoscopicamente.Informe de estudio RNM + ColangioRNM negativo para coledocolitiasis (ev por Cx Dr Zugbe). Se solicitó ANA, ANCA, ENA (pendiente resultado). Evaluada por Gastroenterología, quien sugiere IgG en rango normal (1080), pendiente subunidades IgG4 (Barnafi). Seguimiento ambulatorio por gastro. Optimizar analgesia oral.
-Proporcionalidad terapéutica: Manejo activo.
*Alta hoy , continuidad de vigilancia por HODOM, con control laboratorio semanal y TC abdomen en 15 dias más

PLAN DE MANEJO:

HODOM
Control ambulatorio por gastro

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo. No realizar esfuerzo físico
2. Régimen liviano sin grasas + hidratación oral
3. Tramadol 50 mg 1 comprimido c/12 h + 50 mg SOS vo
4. Paracetamol 500 mg 2 comprimidos c/8 hrs vo
5. Ketorolaco 30 mg c/12 hrs ev SOS (administración SOS por hija enfermera)
6. Amlodipino 5 mg/día vo
7. Quetiapina 25 mg/noche vo
8. Vit D 50.000 UI una vez por semana (dias viernes), completar 8 semanas en total
9. Pendiente resultados examenes de derivacion ANCA, ANA, ENA, IgG4 (Barnafi)
10. Se indica HODOM para Control 1 vez por semana de examenes laboratorio (hemograma, PCR, Crea, BUN, ELP, TP, INR, perfil hepático), vigilancia clínica (fiebre, mayor compromiso del estado general, pensando en sobreinfección colecciones intrabdominales) y realizar UroTC de control en 15 días más (sin no progresa HUN con empeoramiento de colección perirenal, se indica alta)
11. Control CAE Gastroenterología Dr. Arteaga en 1 mes más

EXÁMENES Y RESULTADOS

Laboratorio:
20/03: crea 0,46 ELP n145/3,9/107 PCR 6,3 INR 1,26 GB 5800 Hb 11,8 Plt 324 mil // IgG 1080 (vn 700-1600)
19/03/24: Crea 0.6, Bil T 0.4, PCR 9, Uremia 54, ELP 143/3.5/106, GB 5600, Plaquetas 303000, Hb 12.2, INR 1.17
18/03/24: Crea 0.4, PCR 11.4, ELP 142/3.6/105, GB 5300
17/03/24: Crea 0.5, PCR 15 ELP 143/3.9/105.
13/03/24: Albumina 3.2, Crea 0.4, Amilasa 48, TGO 29, TGP 18, GGT 65, PCR 7.9, ELP 140/3.8/102, Hcto 35.4, Hb 12.1, Leuco 7.200, Plaquetas 221
07/03/2024: PTH: <4,6 (VN 18,5-88)

Otros estudios:
- RNM Abdomen y ColangioRNM (16/03/24): estudio negativo para coledocolitiasis. Atrofia parénquima pancreático y leve dilatación del conducto pancreático en contexto de pancreatitis crónica. Alteraciones inflamatorias subagudas del tejido adiposo que rodea a la cabeza pancreática
- UroTc (13/03/24): signos sugerente de pancreatitis necrohemorrágica que compromete la cabeza, asociado a edema peripancreático y colecciones peripancreáticas y perirrenales derechas que determinan moderada hidroureteronefrosis posiblemente por compresión extrínseca. Calcificaciones pancreáticas posiblemente secuelares. Quistes corticales renales bilaterales de aspecto simple (hasta 15 mm)

Control en: 30 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

Ana Sepúlveda Venegas
MEDICO TRATANTE
13383078-2

JEFE SERVICIO